جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ليلي احمد محمود منصور
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** العياط **العنوان :** الجمله
رقم البطاقة : 28711092100382 **رقم التليفون :** 01117939253 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 09-11-1987 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ليلى احمد محمود منصور
National ID: 28711092100382

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





٠١١٥٧٢٣٣٢٩٨

محمد محمود

تحاليل

مقطمين

NHTMRI

قسم الباثولوجي J

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: ليلى احمد محمود منصور **Age:** 39years **Sex:** female
Request type: مبادره **Sub request type:**
Hospital no: **Pathology no.:**217B-2026
Department: صحه مراه **Date of result:**21/4/2026
Referred by: دلهروه حسن **Date of biopsy:**15/4/2026
Nature of specimen: tru-cut biopsy **I.D. Number:**28711092100382
Clinical diagnosis: Left brest mass

Gross pathology :
Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counterstain. The sections were treated against, ER- PR- Her2- KI67.

Microscopic picture: Section examined revealed core of mammary tissue showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nest, cord and cribriform pattern of anaplastic ductal cells infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to from tubules. There is mild lymphocytic response. No peritumoral lymphovascular emboli or peri neural infiltration in core tissue examined. There is moderate number of mitotic figures. No ductal carcinoma insitu component are seen.

Immunohistochemical Result
ER: Moderate Positive nuclear staining in 80% of tumor cells (Allred Score 7/8).
PR: Moderate Positive nuclear staining in 40% of tumor cells (Allred Score 6/8).
Her2: No membranous staining of tumor cells (Score 0) Her2 Negative.
Ki67: Positive nuclear staining of 80% of tumor cells.

Diagnosis: Left brest mass, tru-cut biopsy:
Invasive ductal carcinoma (NST), Grade II.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Name: ليلى احمد محمود منصور **MR. :** 11222	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with left breast cancer, clinical stage T4d N3, invasive ductal carcinoma grade 2, estrogen receptor 7/8 positive, progesterone receptor 6/8 positive, HER2-negative, Ki-67 80%, and an estimated tumor burden of 55-60 %. Imaging demonstrated inflammatory changes of the left breast with edema, redness, and induration, as well as left infraclavicular and supraclavicular lymphadenopathy (4 × 5 cm and 3 × 4 cm, respectively). Additional findings included right-breast suspicious inflammatory changes, right axillary lymphadenopathy (2 × 3 cm), right supraclavicular nodes (2 × 2 cm), tiny left pulmonary nodules, pre-vascular lymph nodes measuring 39 × 33 mm, multiple mediastinal lymph nodes (24 × 14 mm), and a soft-tissue lesion infiltrating the left side of the sternum. Biopsy of the right axillary node was pending, as were MRI of the brachial plexus and further evaluation of the right axillary nodes. The patient's weight was 89 kg, height 155 cm (BMI 1.94), and she was started on Zoladex, Adriamycin 115 mg/m², and Endoxan 1150 mg. The patient has completed 1 cycle of the Adriamycin 115 mg/m² and Endoxan 1150 mg regimen.

On follow-up, the left breast edema and induration had decreased. Examination confirmed persistent left breast edema and induration, with the right axillary lymph node still pending evaluation. The patient continued on the same regimen of Adriamycin 115 mg/m² and Endoxan 1150 mg, now at cycle 2. The patient has completed 2 cycles of the Adriamycin 115 mg/m² and Endoxan 1150 mg regimen.

تحريرا في ,

التاريخ :	**21-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :2026-1-12

الى من يهمه الامر .....

رقم الاصدار :

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين فقط من منتفعى: الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "الاسر العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمراة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التامينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) لولى احمد محمود منصور بطاقة رقم 28711092100382

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التامينات الاجتماعية بفرد عدم الانتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتامين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التامين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :2026-1-12

الموظف المختص

احمد ياسر

ادارة مركز نظم المعلومات

يعتمد...

مسلسل 10460919

ادارة ال...

الخطاب سارى لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار الا فى حاله تغير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية او وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :2026-4-12

جهه الاصدار :فرع الجيزة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) ليلى احمد محمود منصور بطاقة رقم 28711092100382

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :2026-4-12

الموظف المختص

احمد ياسر

إدارة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،

مسلسل 1946919

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	ليلى احمد محمود منصور	**Case No.**	**359773**
Sex/Age	**Female 38 Y**	**Patient No.**	**26005**
Registered Date	**23/8/2026 08:44:55 AM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**15/9/2026 03:18:49 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**14/10/2026 01:31:22 PM**	**Pathology No.**	**2613/26**

Pathology Report

Clinical Data: Right pathological axillary lymph node.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 17/08/2026, at 2:36 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
- Two grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 0.8 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
- Histologic examination reveals fibrotic cores with metastatic deposits likely of breast origin

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- Consistent with fibrotic cores with metastatic deposits likely of breast origin.
- ER: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (score 6/8).
- PR: Weak nuclear reaction in 1% of tumor cells (score 3/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in less than 10% of tumor cells (Ultra-low, score 0+).
- Ki67%: 50%.

Conclusion:
Right axillary lymph node, Tru-cut biopsy:
- Consistent with fibrotic cores with metastatic deposits likely of breast origin.
- ER: Positive (score 6/8).
- PR: Positive (score 3/8).
- Her2: Ultra-low (score 0+).
- Ki67%: 50%.

***Scoring system: "ER, PR"*
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1%

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي انترناشونال

Patient Name	ليلى احمد محمود منصور	**Case No.**	**359773**
Sex/Age	**Female 38 Y**	**Patient No.**	**26005**
Registered Date	**23/8/2026 08:44:55 AM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**15/9/2026 03:18:49 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**14/10/2026 01:31:22 PM**	**Pathology No.**	**2613/26**

and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

***** Scoring system: "Her2"***

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]
Bone Scan

Name : Leila Ahmed Mahmoud Mansour
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Date : 02-10-2026 09:19
Medical No. : 474806

Tc-99m MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:
39-year-old female patient with history of left breast cancer received chemotherapy and referred for skeletal survey.
Technique: Anterior and posterior whole-body scans 2 hours post injection of 20 mCi of the tracer.
Findings :

- The surveyed skeleton revealed few randomly distributed foci of variable tracer uptake keeping with bone secondaries. They are located at the sternum, around both shoulders and costo-vertebral junction of left 4th rib.
- Otherwise rest of the surveyed skeleton is unremarkable

IMPRESSION

- Few active osseous lesions at the aforementioned sites most likely metastatic.
- Follow up bone scan to monitor response to therapy.

Much obliged
Dr. Alaa Nagy, MD
Nuclear medicine

NILE DIAGNOSTIC CENTER

[[DOCTYPE:MRI]]
M.R.I

جوستاف روسي انترناشونال

Patient's Name:	**Laila Ahmed Mahmoud Mansour**
Date:	**2026-09-08**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

MRI OF THE CERVICAL SPINE:

TECHNIQUE:

-Sagittal and axial T1WIs.
-Sagittal and axial T2WIs.
-No contrast.

FINDINGS:

-Loss of cervical curve(straightening).

– Normal sagittal dimensions of the cervical bony spinal canal.

– Low-grade dehydration is seen at different disc levels.

–No cervical collapse or disc space narrowing.

- C5-6 posterior central disc protrusion ,measuring about 2.9 mm in axial plane1.5 mm in sagittal plane,effacing the anterior epidural subarachnoid space,gently impressing the ventral aspect of the cord and not encroaching upon the exit neural foramina of C5 nerve root sleeves. No osteoarthropathy of the neurocentral joints or hypertrophy of ligamentum flavum seen at this level.

- C6-7 posterior disc protrusion is seen,measuring about 1.9 mm in axial plane,1.6 mm in sagittal plane,effacing the anterior epidural subarachnoid space,gently impressing the ventral aspect of the cord and mildly encroaching upon the exit neural foramina of C6 nerve root sleeves. No osteoarthropathy of the neurocentral joints or hypertrophy of ligamentum flavum seen at this level.

–No dislocation or subluxation of the articulation.

-No abnormal signals seen in the scanned bone marrow,impressive of diffuse infiltrative bone marrow disease or in the scanned cord.

–No intra, or paravertebral masses or collection.

–Normal cervico-cranial junction.

IMPRESSIONS:

- C5-6 posterior central disc protrusion and not encroaching upon the exit neural foramina of C5 nerve root sleeves. No osteoarthropathy of the neurocentral joints or hypertrophy of ligamentum flavum seen at this level.

- C6-7 posterior disc protrusion and mildly encroaching upon the exit neural foramina of C6 nerve root sleeves. No osteoarthropathy of the neurocentral joints or hypertrophy of ligamentum flavum seen at this level.

Prof/Hanan El-Ahwal